HELP_Organi_P08 — Groupe A — Audits LOT 1 à 8 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 8 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

A-060 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10__export_GoogleDoc__v2.html › D5.10 › Fenêtre 3.10 › exemple clinique › prise en charge ; constats L5-M48, L5-M49, L5-M50, L5-M53, L5-L103, L5-L107, L5-L108

Contexte : Le cours propose l'oxygène normobare seul avec une HbCO de 28–34 % alors que son tableau fixe l'OHB au-delà de 25 %, cite des chiffres de Tox Info Suisse incohérents, rend les détecteurs de CO « obligatoires » et ne cite que le CDC. L'audit cite l'ECHM 2016 relu via synthèses.

Question : Quels critères d'oxygénothérapie hyperbare dans l'intoxication au CO fixe la conférence de consensus européenne la plus récente (ECHM 2016 ou ultérieure) et quelle conduite recommande Tox Info Suisse (grossesse, enfant, durée d'O2 normobare) ? Quels centres hyperbares suisses sont disponibles ? Combien de cas d'intoxication au CO rapporte le dernier rapport annuel de Tox Info Suisse ? Une base légale suisse ou cantonale impose-t-elle des détecteurs de CO ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-056 — Moyenne — LOT 5 · SSP G5

Emplacement : LOT_5_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Bloc 2 › badges des DX.1 à DX.10 ; constats L5-M04, L5-M06, L5-L24, L5-L25, L5-L55, L5-L56, L5-L57

Contexte : Les badges des 10 DX totalisent exactement 100 % ; les chiffres 8–15 %, > 20 %, > 30 % sont attribués à la SSMIG et à la Revue Médicale Suisse ; ceux du sepsis, du trouble panique et des troubles électrolytiques à la SSI, la SSCM, l'OFSP, la SSPP et la SSN, sans document.

Question : Quelles données suisses ou européennes chiffrent : les motifs « malaise / sensation de maladie » en soins primaires, l'incidence et la mortalité du sepsis en Suisse (OFS, plan national), la prévalence du trouble panique (Obsan, ESS) et la fréquence de l'hyponatrémie chez les patients hospitalisés ? Donne année, population et URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-061 — Moyenne — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10__export_GoogleDoc__v2.html › D5.8 › 10. Arbre décisionnel ; constats L5-L96, L5-L100, L5-L101

Contexte : Le traitement de l'hypoglycémie de l'arbre D5.8 est illisible ; le pourcentage de réduction du délirium par un programme de prévention et les fréquences attribuées à la SPSG n'ont pas de source.

Question : Quelle recommandation suisse ou européenne la plus récente (SPSG, European Delirium Association, NICE CG103 en comparaison) fixe la prévention et le dépistage du délirium (4AT, CAM) ? Quelles données chiffrent l'effet des programmes multicomposantes (HELP) et la prévalence du délirium à l'hôpital en Suisse ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-062 — Moyenne — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5__export_GoogleDoc.html › D5.3 › 1. Définition et sémantique de la plainte ; constats L5-L59, L5-L60

Contexte : Le cours définit le trouble à symptomatologie somatique par l'absence de substrat organique et le pic d'attaque de panique par « < 10 minutes » (DSM-IV) ; l'audit renvoie à la CIM-11 non relue.

Question : Quelles définitions la CIM-11 (6C20 trouble de détresse corporelle ; 6B01 trouble panique) et le DSM-5-TR donnent-elles, et quelle recommandation suisse ou européenne traite leur prise en charge (benzodiazépine de courte durée, ISRS, psychothérapie) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-065 — Haute — LOT 6 · SSP G6

Emplacement : LOT_6_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › V6 › D6.9 › point 5 « Anamnèse et drapeaux rouges » ; constats L6-M15

Contexte : La neutropénie fébrile n'est ni définie ni associée à sa conduite ; l'audit cite l'ESMO 2016 (neutrophiles < 0,5 G/L, T > 38,3 °C ou 2 × > 38,0 °C, bêtalactamine antipseudomonas dans l'heure).

Question : La recommandation ESMO sur la neutropénie fébrile a-t-elle été mise à jour après 2016 ? Quelle définition, quel score de risque (MASCC) et quelle antibiothérapie probabiliste (molécule, dose, délai) recommandent l'ESMO récente et la SSI ou un centre suisse d'oncologie ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-066 — Haute — LOT 6 · SSP G6

Emplacement : LOT_6_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › V6 › SSP G6 › point 11.B « Moyens » (même défaut dans les 11 points 11.B) ; constats L6-M10, L6-L15, L6-M14, L6-L25, L6-M23

Contexte : Aucun des 11 points 11.B ne décrit un médicament (paracétamol, antibiotiques de la pneumonie, de la pyélonéphrite, de l'érysipèle, de l'arthrite septique) ; le CURB-65 est cité sans items ; le seuil leucocytaire du liquide synovial est vague. L'audit cite Lim 2003 et Margaretten 2007.

Question : Quelles antibiothérapies (molécule, dose, durée) recommandent les guidelines SSI (ssi.guidelines.ch) en vigueur pour la pneumonie communautaire, la pyélonéphrite, l'érysipèle et l'arthrite septique de l'adulte, et quels scores de gravité (CURB-65, PSI) utilisent-elles ? Quelle dose maximale de paracétamol (Dafalgan®) et quelles réductions (hépatopathie, < 50 kg) prévoit l'AIPS ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-069 — Haute — LOT 6 · SSP G6

Emplacement : LOT_6_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Appel A V5 › Bloc 1 › point 12 Prévention ; constats L6-L37

Contexte : L'Appel A écrit une vaccination antipneumococcique annuelle ; l'audit cite le Plan de vaccination suisse 2024 et le Bulletin OFSP 4/2024 (dose unique de vaccin conjugué dès 65 ans et chez les personnes à risque).

Question : Que recommande le Plan de vaccination suisse en vigueur (OFSP/CFV, édition 2025 ou 2026) pour la vaccination contre les pneumocoques (vaccin conjugué PCV15, PCV20 ou PCV21, âge, groupes à risque, nombre de doses, rappel) et contre la grippe (groupes cibles, période) ? Quelles différences avec l'édition 2024 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-067 — Moyenne — LOT 6 · SSP G6

Emplacement : LOT_6_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › V6 › SSP G6 › point 8 « Critères » ; constats L6-M18, L6-L17, L6-L23

Contexte : Le point 8 ne donne ni seuil de fièvre par site de mesure, ni définition chiffrée de la fièvre d'origine inconnue, ni valeur pour une « CRP basse ».

Question : Quels seuils de fièvre par site de mesure (rectal, buccal, tympanique, axillaire) et quelle définition actuelle de la fièvre d'origine inconnue (durée, bilan minimal) retiennent les sources européennes les plus récentes (Bleeker-Rovers, recommandations néerlandaises ou suisses) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-068 — Moyenne — LOT 6 · SSP G6

Emplacement : LOT_6_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › V6 › SSP G6 › point 2 « Épidémiologie » (11 occurrences de « donnée non trouvée », HELP Q23 à Q43) ; constats L6-M21

Contexte : L'épidémiologie est « donnée non trouvée » dans les 11 monographies alors que l'OFSP publie des chiffres de déclaration obligatoire ; l'audit ne les a pas recopiés.

Question : Quels nombres annuels de cas (dernière année disponible) publie l'OFSP pour le paludisme importé, les méningococcies et pneumococcies invasives, la salmonellose, la campylobactériose, la tuberculose et la grippe (Sentinella) ? Donne l'URL et l'année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-070 — Moyenne — LOT 7 · SSP G7

Emplacement : LOT_7_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Point 4 › paragraphe « Les autres causes restent accessibles… » (répété dans Bloc 2 › Algorithme › dernière branche) ; constats L7-M02, L7-M05

Contexte : Le cours ne nomme ni le carcinome médullaire de la thyroïde ni le VIPome et ne cite aucun médicament ni mécanisme pour les flushs médicamenteux et alcooliques ; la seule source du bilan est La Revue du Praticien 2021 (française), le texte intégral de S2 n'a pas été lu.

Question : Quelle source suisse ou européenne (ENETS pour les tumeurs neuroendocrines, revue suisse) décrit le bilan d'un flush (sérotonine/5-HIAA, chromogranine, calcitonine, VIP, métanéphrines, tryptase) et la liste des médicaments responsables (classes, DCI, mécanisme) ainsi que le mécanisme du flush alcoolique (ALDH2) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-072 — Moyenne — LOT 7 · SSP G7

Emplacement : LOT_7_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Point 2 › fenêtre « Les indicateurs doivent préciser leur population et leur définition » › tableau › ligne Prévalence ; constats L7-L06

Contexte : Le point 2 ne donne aucun chiffre ; l'audit demande les prévalences publiées dans S10 (symptômes vasomoteurs), S11 (rosacée) et S5 (anaphylaxie).

Question : Quelles prévalences ou incidences européennes ou suisses sont publiées pour les symptômes vasomoteurs de la ménopause, la rosacée, l'anaphylaxie et les tumeurs neuroendocrines sécrétantes ? Donne population, année et URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-078 — Haute — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 2 (Épidémiologie) ; constats L8-M16, L8-L15, L8-L47, L8-L32, L8-L49, L8-M22, L8-L13, L8-M37

Contexte : Le cours cite 200–300 cas annuels et 70 % de survie sous ECLS attribués à un « Registre suisse » non identifié, un tiers de décès traumatiques sur place (Knapp 2025 : 15 %), un «

HOPE-Score 2.0 » d'intelligence artificielle, une mortalité « proche de 100 % » et des sources SGNOR 2023 et RMS 2022 introuvables.

Question : Quelles données publiées (OFS, International Hypothermia Registry, SLF, études suisses de Berne et Lausanne) chiffrent l'hypothermie accidentelle et les accidents d'avalanche en Suisse, la survie sous ECLS et la part de décès traumatiques ? Existe-t-il un document SGNOR/SSMUS sur l'hypothermie (titre, année, URL) et une version actualisée du score HOPE (publication, validation) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-080 — Haute — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau comparatif › ligne DX.5 › conduite immédiate ; constats L8-M26, L8-L27

Contexte : Le cours ne donne pas la dose de naloxone ; la spécialité suisse est Naloxon OrPha® 0,4 mg/mL, signalée non commercialisée par ch.oddb.org.

Question : Quelles spécialités de naloxone injectable et nasale (Naloxon OrPha®, Nyxoid®…) sont commercialisées en Suisse en 2026, et quelle dose initiale, titration et répétition prévoit leur AIPS dans l'intoxication aux opioïdes ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-081 — Haute — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau comparatif › ligne DX.8 › conduite immédiate ; constats L8-M27, L8-L26

Contexte : Le cours prescrit la thiamine à « forte dose » sans dose ni voie ; ch.oddb.org liste Benerva® en comprimés 100/300 mg et ampoules, dose IV non trouvée.

Question : Quelle forme injectable de thiamine est autorisée en Suisse (Benerva® ampoules ou autre) et quelle dose, voie, rythme et durée recommandent l'AIPS et la source européenne la plus récente (EFNS 2010 ou ultérieure) pour la prévention et le traitement de l'encéphalopathie de Wernicke ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-082 — Haute — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau comparatif › colonne « Conduite immédiate » (DX.6, DX.7, DX.10) ; constats L8-M28, L8-L28

Contexte : Le tableau comparatif cite glucose 40 % (« G40 »), noradrénaline, hydrocortisone (Solu-Cortef®) et NaCl 0,9 % sans dose ni spécialité.

Question : Quelles solutions de glucose IV sont autorisées en Suisse (10, 20, 40, 50 %) et quelle quantité de glucose en grammes recommande-t-on chez l'adulte hypothermique hypoglycémique ? Quelle dose de noradrénaline et quel remplissage recommande l'ERC 2025 chez le patient hypothermique ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-077 — Moyenne — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 1 › point 7.2 (Syndrome de « Rescue collapse ») ; constats L8-M19, L8-M20, L8-M21, L8-L54, L8-L31, L8-L21, L8-L17, L8-L50

Contexte : Le cours confond collapsus de sauvetage et afterdrop, fixe une vitesse de réchauffement de 1–2 °C/h et une variation horaire de la kaliémie sans source, attribue 6 % par degré au métabolisme global et une sensibilité de 100 % à la thermométrie œsophagienne ou épitympanique.

Question : Quelles sources européennes (ERC 2025, ICAR, revues de Paal ou Brugger) décrivent le collapsus de sauvetage et l'afterdrop, les vitesses de réchauffement attendues selon la méthode (passive, active externe, ECLS), la température des liquides perfusés, l'évolution de la kaliémie au réchauffement et la précision des méthodes de mesure de la Tcc (œsophagienne, épitympanique) ? Quelle variation du métabolisme par degré la physiologie retient-elle ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P08 — 16 questions : A-060, A-056, A-061, A-062, A-065, A-066, A-069, A-067, A-068, A-070, A-072, A-078, A-080, A-081, A-082, A-077